BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS

Traumatologie

FMA des chefs d'agrès
2025 - 2026



Historique de la traumatologie en FMA

- Premier thème de traumatologie en FMA lors de la 1ère FMA en 2008-2009

- Algorithme d'immobilisation du rachis lors de la FMA 2019-2020

- Traumatologie encore lors de la FMA 2022-2023 :
  - Car mise à jour du BSP 200.2 et réapparition d'EI
  - Objectifs : maitriser le bilan traumatologique, savoir qui immobiliser et qui médicaliser

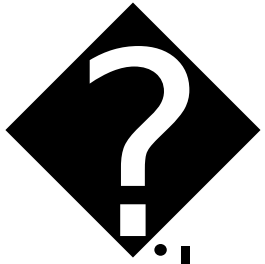
- L'an d'après, rappel en traumatologie pour la FMA 2023-2024

- Pas de traumatologie en 2024-2025…

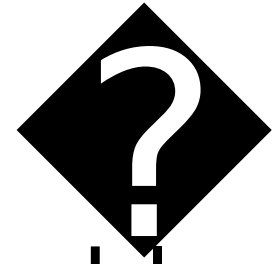


Est-ce que toutes ces FMA
ont servi à quelque chose ?





Pas autant qu'on aurait aimé,
car il y a beaucoup d'évènements indésirables
en lien avec de la traumatologie !



Qui se souvient de quoi on avait parlé durant
toutes ces FMA ?

1er message

Estafilade ≠ plaie pénétrante

- Il existe une différence entre une estafilade (long et non pénétrant) et une plaie par lame pénétrante.
- Plus la plaie est de petite taille, plus la lame a pu aller en profondeur.
- Toute plaie thoracique autre qu'une égratignure :
  - Est grave jusqu'à preuve du contraire !
  - Doit faire rechercher une détresse respiratoire et/ou une détresse circulatoire qui peuvent mettre du temps à s'installer, ce d'autant que les secours arrivent vite !
  - Doit faire demander une équipe médicale !

Gravité ?

Pas grave…



Grave !



Gravité ?

Grave !



Pas grave…



Grave !



2ème message

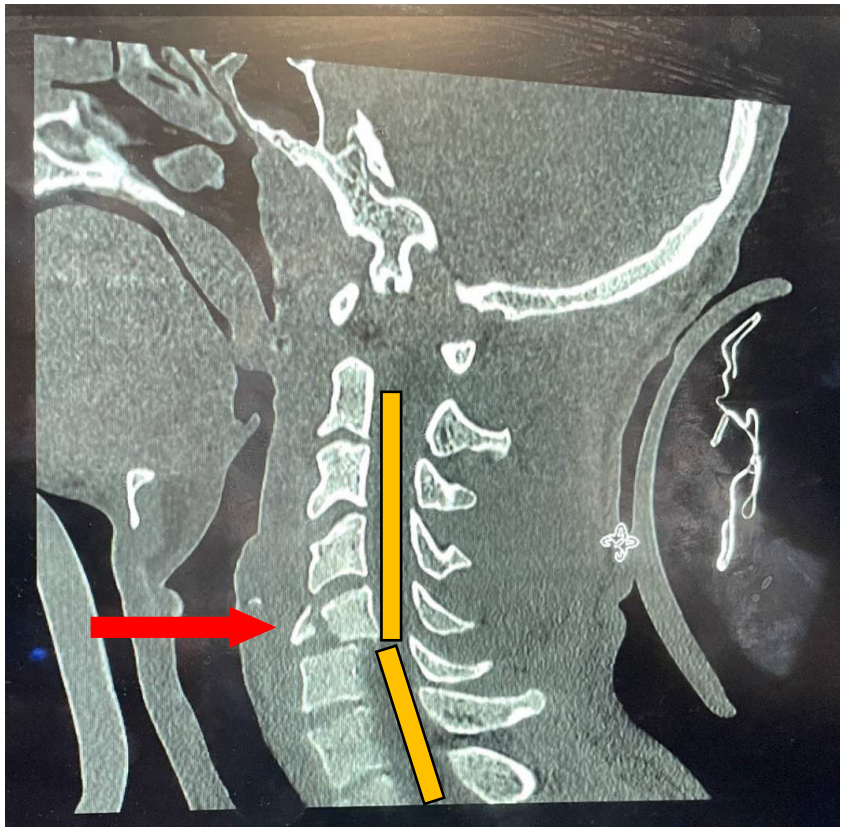
L'atteinte de la tête et du tronc est souvent grave

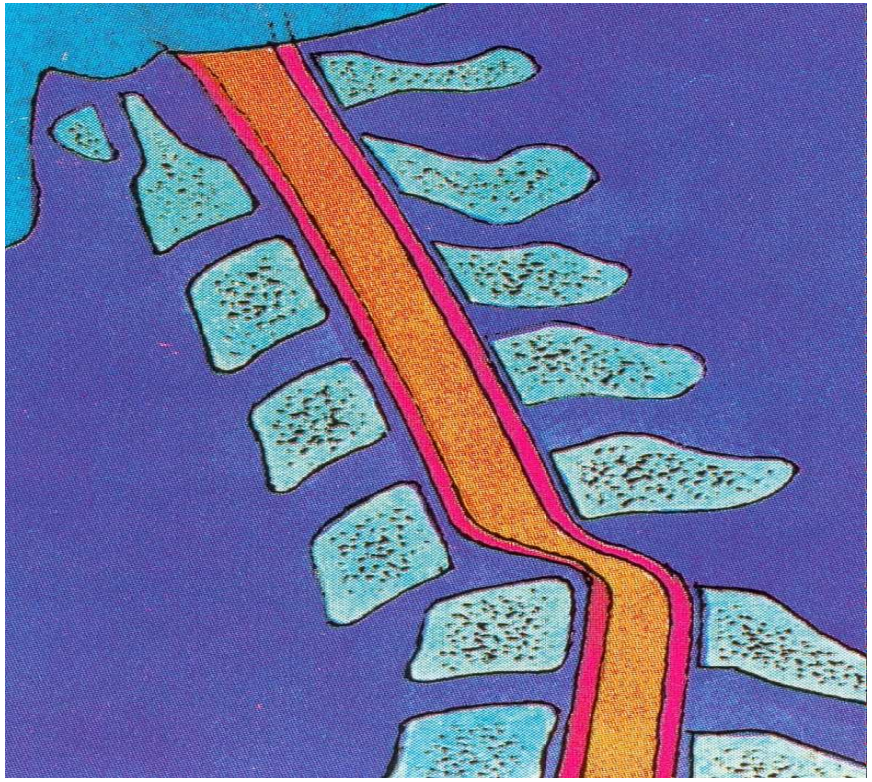
- Les signes d'appel localisés au niveau de la **tête et du tronc (thorax, abdomen, bassin)** doivent être considérés comme les témoins de **lésions internes potentiellement graves**.
- Une lésion du tronc peut donner une détresse respiratoire et/ou une détresse circulatoire.
- **L'arrivée précoce** des secours auprès d'un traumatisé grave explique que **les détresses vitales peuvent être masquées** d'où l'importance de **l'analyse des circonstances** de l'accident et de **la surveillance** : l'apparence initiale de la victime peut être rassurante.

- Une vitesse de 50 km/h équivaut à une chute de 10 m.
- Douleur ou nouveau signe = lésion.

3ème message

Traumatisme
+ douleur du rachis
+ trouble S ou M de membre(s) même intermittent
= traumatisé médullaire
= UA = équipe médicale





Il faut utiliser les bons mots !

Circonstances de l'appel des secours	Bilan et évolution
une femme et son enfant (passager du bus) se trouvaient a l'arrière du bus lors du choc avec le PL	se plaint de douleur au niveau de la cage thoracique sans douleur thoracique pas de déformation pas de PCI pas de chute pas de TC pas de signe de detresses respiratoire circulatoire neurologique ne souhaite pas de déplacer a l'hôpital

- La cage thoracique c'est justement le thorax ! Il y a donc ici une douleur thoracique !
- Par ailleurs, une douleur thoracique après un accident, ça s'appelle un traumatisme thoracique.
- Il faut donc écrire : traumatisme thoracique et ne pas avoir peur du mot !
- Un traumatisme thoracique doit faire rechercher une détresse circulatoire et une détresse respiratoire (ce qui a été fait ici).

Cas n°1

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

MAIN COURANTE OPERATIONNELLE

Dossier imprimé le : [redacted]

Fiche décisionnelle : ATR02 - AVP

Mission BSPP - Procédure Blanche [redacted]

Nb LSO impliqués : 1 **Nb moyens sur interventions :** 1 **Nb personnels :** 3

N° Intervention : [redacted] CSTC : [redacted] Opérateur : [redacted]

1er départ : **200 - Accident de circulation**

Adresse d'intervention : [redacted]

Numéro Requérant : [redacted] **Police** Numéro Impliqué : [redacted]

Heure de décroché : **20:41:38**

Informations requérants :

SCOOTER VL -- H 20 AINE -- CONSCIENT -- DLRS ABDOS -- POLICE SLL



- Bilan du chef d’agrès en NU



BSPP

200 - ACCIDENT DE CIRCULATION [redacted]

[redacted] (Police) SCOOTER VL -- H 20 AINE -- CONSCIENT -- DLRS ABDOS -- POLICE SLL

MOTIF DE RECOURS

AVP Cyclomoteur, Scooter (<125cm3)

IDENTIFICATION

Catégorisation	Urgence Relative
Prénom **Nom**	[redacted]
Né(e) le	[redacted] (18 ans)
Sexe	M
Statut	Civil

ANTÉCÉDENTS

Aucun antécédent

TRAITEMENTS

Aucun traitement

ALLERGIES

Aucune allergie

[redacted]

BILAN STANDARD | GESTES | AVP | ADMIN.

Circonstances de l'appel des secours

un homme de 18 ans conducteur d'un scooter est victime d'un AVP

Bilan et évolution

conscient et allongé a notre arrivée.

douleur costale côté gauche amplifiée a l'inspiration, sans déformation, sans hématome chiffré a 3/10 a l'EN
bonne motricité-sensibilité des 4 membres
pas de fourmillements
pas de douleur abdominale, abdomen souple et non douloureux a la palpation
sensation de faiblesse.
extrémités froides
pales.

	Initial (20:56)	21:13
Glasgow	15 (Y4 V5 M6)	--
FR	15 cpm	-- cpm
SpO2	100 %	-- %
FC	79 bpm	70 bpm
PA Bras gauche	102/61 mmHg	126/51 mmHg
PA Bras droit	94/65 mmHg	---/--- mmHg
Température	35.5 °C	-- °C
Douleur (EN)	3	--
Glycémie	6.9 mmol/L	-- mmol/L

[redacted]

RESPIRATION

BILAN STANDARD | GESTES | AVP | ADMIN.

CONTEXTE

Type de voie	Voie d'agglomération
NATURE DE L'ADVERSAIRE	VL
Vitesse approximative de l'adversaire	0 km/h

ELÉMENTS LIÉS À LA VICTIME

Position de la victime dans le véhicule	Conducteur
Pas de Éjection du véhicule	✓
Pas de Autre personne décédée dans le véhicule	✓
ELÉMENTS DE PROTECTION (MULTISELECT)	Autre Casque
Casque fixé ?	
Airbag intégré (veste, etc.)	Absent

VÉHICULE DE LA VICTIME

Choc	Frontal
Position de la victime par rapport à l'adversaire	Derrière
Pas de Véhicule en feu	✓
Vitesse approximative du véhicule de la victime	30 km/h

Observations

est rentré a l'arrière d'une voiture a l'arrêt a 30 km/h
casque jet, pas de déformation du casque
présence de gant

Rassurant ?

Pas de déficit SM des membres

Abdomen indolore

GCS 15, pas de PCI

FR et SpO_2 normales

FC normale

MHTA néant

Pas d'éjection, casque intact

Inquiétant ?

AVP scooter arrêt net contre obstacle

Traumatisme thoracique !

PA basse !
Sensation de faiblesse
Extrémités froides
Pâleur

Pas d'immobilisation

Incertain ?

Cinétique 30 km/h

Manquant ?

Détresse respiratoire ?

Crâne ?

Rachis ?

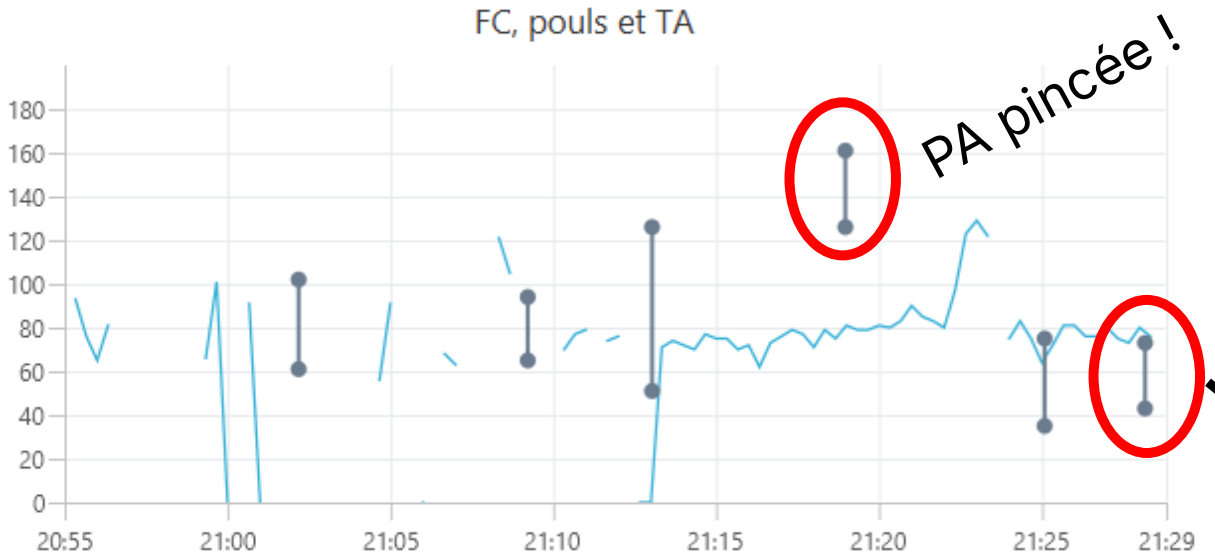
Bassin ? (mentionné mais non noté)

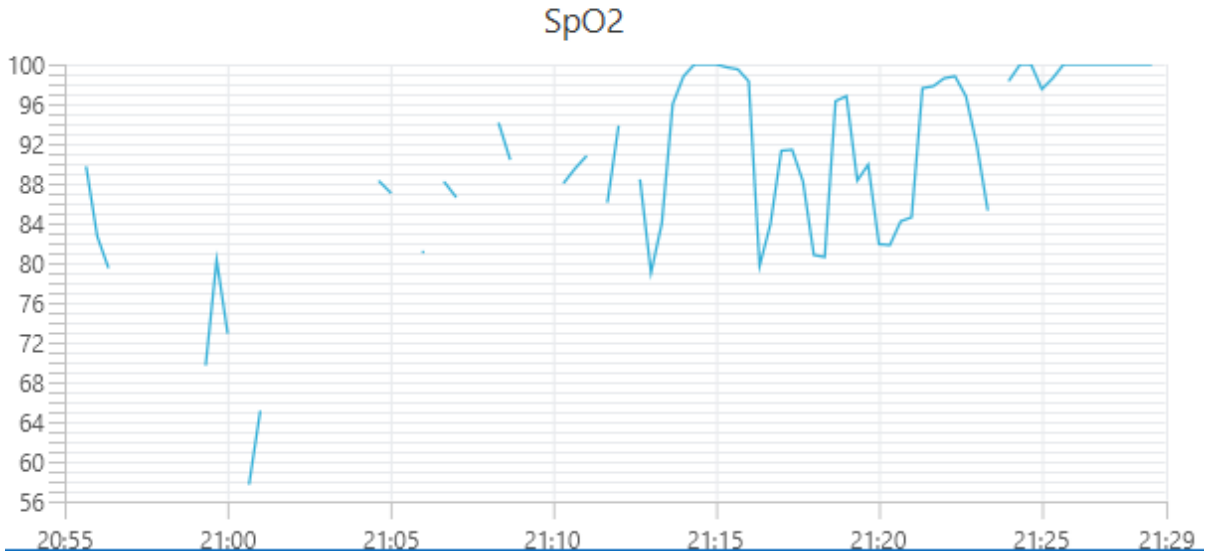
Membres ?

État des véhicules
Photo ?

Victime intoxiquée ?
Autre victime ?

Il y avait d'ailleurs d'autres signes qui auraient du mettre le chef d'agrès sur la piste de la détresse circulatoire !





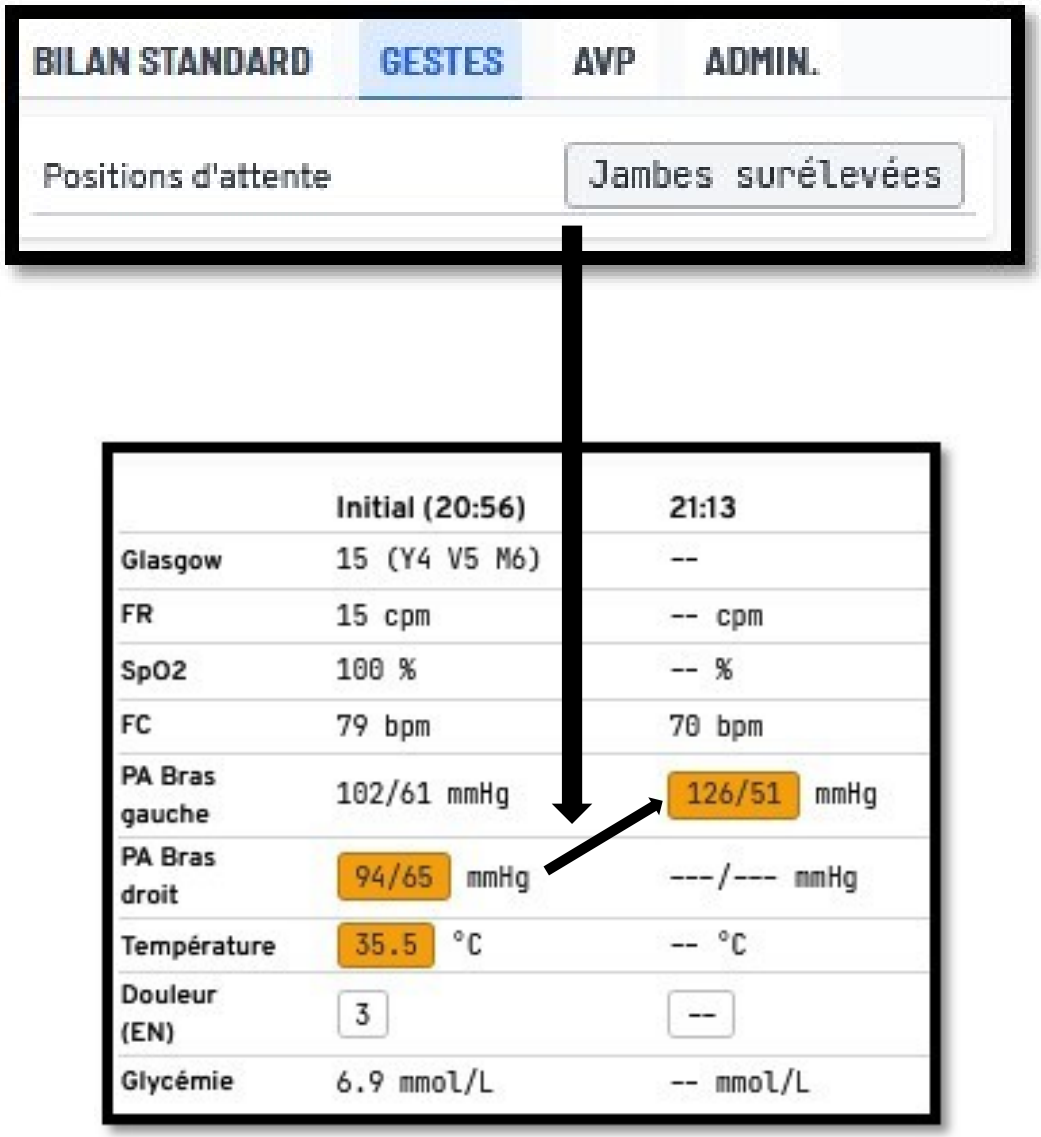
Que peut-on dire des prises de PA ?

Que peut-on dire de la saturation ?



Personne ne voit cette baisse (ces baisses !) de la PA à la coordination médicale, car le bilan du CA est déjà passé !

Il y avait d'ailleurs d'autres signes qui auraient du mettre l'OCM sur la piste de la détresse circulatoire !

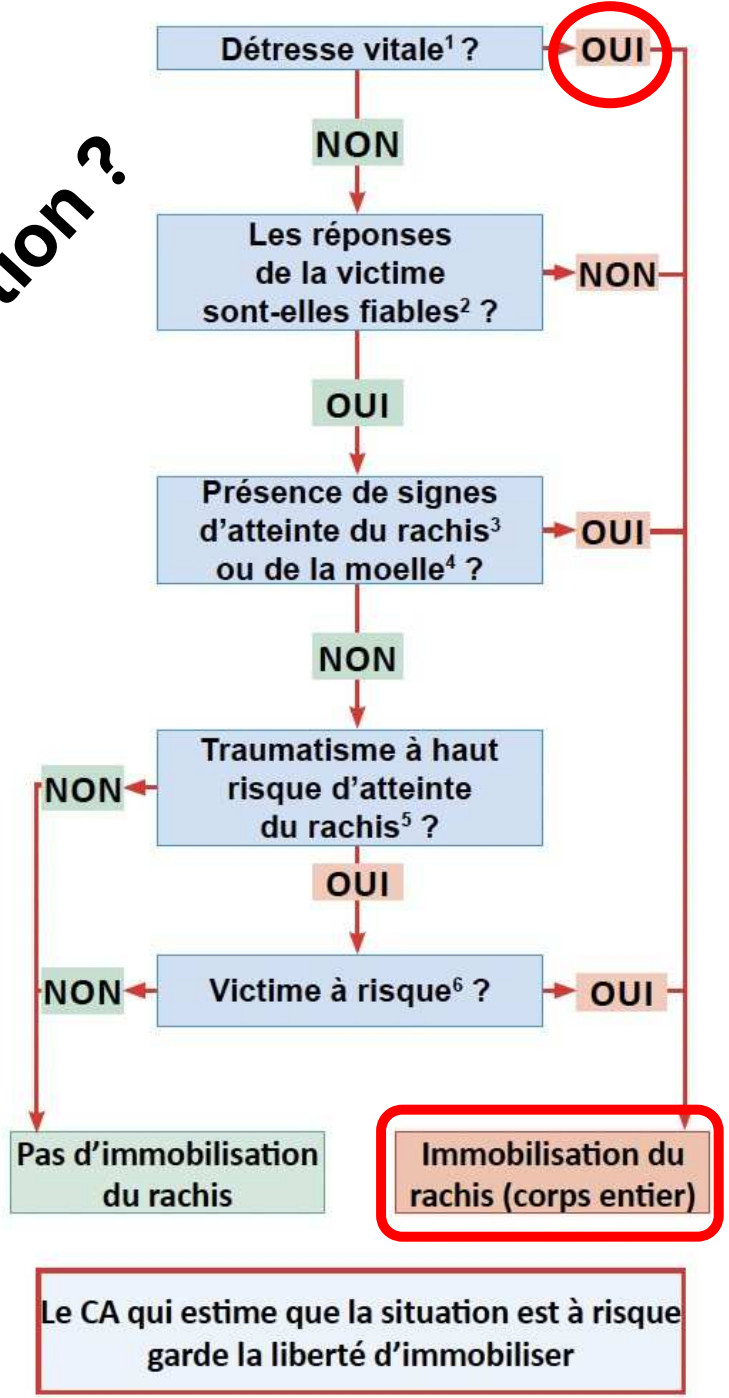


L'application de la routine aurait permis à l'OCM de découvrir que la victime a été installée en position allongée jambes surélevés ce qui permet de comprendre l'amélioration de la PA à 21H13.

Au total

- Le CA et l'OCM n'ont pas détecté la détresse circulatoire :
  - Mauvaise **conscience de situation** due à une mauvaise compréhension des signes.
  - La **prise de décision** du CA (appeler en urgent pour demander une équipe médicale) et celle de l'OCM (en parler au médecin) ne sont donc pas bonnes.
  - La **perception des signes** était pourtant présente et notée dans eFiBi :
    - baisse la PA, PA pincée, correction de la PA basse par surélévation des jambes, asthénie importante, extrémités froides, pâleur
- Au SAU :
  - Majoration de la détresse circulatoire aiguë ;
  - Le scanner révèle une fracture de rate due à une fracture de côte et une hémorragie intra-abdominale ;
  - Le patient est opéré en urgence (contrôle de l'hémorragie par ablation de la rate).

Et l'immobilisation ?



(1) Victime présentant une détresse vitale

- ❑ Présence d'une détresse vitale :
  - PCI ou Glasgow < 14.
  - Absence de pouls radial au bilan primaire ou PAS <90 mmHg.
  - Signes détresse respiratoire.

(2) Victime dont les réponses sont qualifiées de NON fiables:

- ❑ Non coopération, difficultés de communication (agitation, barrière de la langue).
- ❑ Influence de l'alcool ou d'autres drogues.
- ❑ Présence d'une atteinte traumatique sévère (tête – tronc)
- ❑ Douleur distractive associée à une situation à haut risque du rachis décrite dans **(5)**

(3) Signes d'atteinte du rachis à rechercher dans l'ordre :

- ❑ 1/ Déformation évidente du rachis.
- ❑ 2/ Douleur spontanée siégeant au niveau du rachis.
- ❑ 3/ Douleur à la palpation prudente du rachis.
- ❑ 4/ Raideur de la nuque empêchant de tourner la tête.
- ❑ 5/ Douleur du rachis à la mobilisation, à la marche.

(4) Signes d'atteinte de la moelle épinière

- ❑ Perte ou diminution de la force musculaire ou de la motricité des mains ou des pieds (difficulté de serrer les mains, de bouger les orteils, de bouger un ou plusieurs membres).
- ❑ Sensibilité :
  - perte ou diminution de la sensibilité des membres supérieurs ou inférieurs.
  - engourdissement, fourmillements, décharges électriques au niveau des membres (paresthésies).
- ❑ Perte des urines ou des matières fécales.
- ❑ Erection.

(5) Situations à haut risque de fracture du rachis

- ❑ Chute sur la tête d'une hauteur > 1 mètre comme lors d'un plongeon (rachis cervical) ou chute sur les pieds ou les fesses d'une hauteur > 3 mètres (rachis dorso-lombo-sacré).
- ❑ Occupant d'un véhicule accidenté à grande vitesse (vitesse > 40 km/h) ou avec arrêt brutal contre un obstacle ou décélération sur une courte distance < 10m ou déformation de l'habitacle.
- ❑ Absence de port de ceinture de sécurité (et déclenchement des airbags).
- ❑ Retournement d'un véhicule (tonneaux) à la suite d'une collision.
- ❑ Victime éjectée d'un véhicule lors de la collision.
- ❑ Accidents avec des véhicules à moteur de loisir (jet-ski, quad, kart, trottinettes électriques…).
- ❑ Accident de 2 roues - conducteur ou passager(s).
- ❑ Piéton renversé.
- ❑ Chute de cheval.

(6) Antécédents à risque

- ❑ Traumatisme vertébral ancien (fracture, luxation)
- ❑ Chirurgie de la colonne vertébrale.
- ❑ Maladie de la colonne vertébrale ou des os qui fragilise la colonne vertébrale (ostéoporose)

Cas n°2

- Appel 18



BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

MAIN COURANTE OPERATIONNELLE

Dossier imprimé le : [redacted]

Fiche décisionnelle : ATR07 - PLAIE MEMBRE [redacted]

Mission BSPP - Procédure Blanche

Nb LSO impliqués : 1 **Nb moyens sur interventions :** 1 **Nb personnels :** 3

N° Intervention : [redacted] CSTC : [redacted] Opérateur : [redacted]
1er départ : **302 - Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...)**
Adresse d'intervention : [redacted]

Numéro Requérant : [redacted] **Téléphone portable** Numéro Impliqué : [redacted]
Heure de décroché : **17:20:01**
Informations requérants :

vp ** homme 26 ans ** s'est coupé avec un verre ** plaie au dos ** saignement ** Ø pci **

info adresse :

info site :

- Bilan en non urgent du CA



ANTÉCÉDENTS

Aucun antécédent : Oui

FACTEURS DE RISQUE CV

Pas de Tabagisme // Pas de Diabète // Pas de Hypertension

TRAITEMENTS EN COURS

Aucun traitement : Oui

ALLERGIES

Aucune allergie : Oui

MOTIFS DE RECOURS

Autre motif médical non classé ailleurs

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : un homme de 25 ans s'est coupé dans le dos avec du verre en se relevant dans sa salle de bain

Situation à l'arrivée des secours : plaie suturable 10 cm sous omoplate droite
plaie non soufflante
pas de difficulté respiratoire
pas de cyanose
non Hémorragique

CIRCULATION

Pouls régulier // Pouls radial perçu

PARAMÈTRES VITAUX

	17:28
FC	116
PA BG	105/69
FR	16
SpO2	98 %
GCS	Y4 V5 M6 (15)

COMMENTAIRE

non soufflant // non pénétrant // pas de diff respi //

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

Rassurant ?

Plaie non hémorragique

Pas de signes respiratoires

Non soufflante

GCS 15, pas de PCI

FR et SpO_2 normales

MHTA néant

Inquiétant ?

Plaie thoracique profonde

Profonde

Tachycardie

PA un peu basse

Manquant ?

Plusieurs prises de constantes

Incertain ?

Réalisation du pansement

Est-ce que c'est une estafilade ?



Quel(s) organes cette plaie est-elle susceptible d'atteindre ?

Quelle(s) détresse(s) cette plaie doit-elle faire rechercher ?

Doit-on demander une équipe médicale ?

D



G

Cas n°3

- Contact opérateur 18 niveau 2 – Médecin CM



BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

MAIN COURANTE OPERATIONNELLE

Dossier imprimé le : [redacted]

Fiche décisionnelle : ACI03 - ARME BLANCHE SUITE A AGRESSION/TS

Mission BSPP - Procédure Rouge [redacted] 12:56:52
Mission BSPP - Procédure Orange 12:50:36

Nb LSO impliqués : 2 **Nb moyens sur interventions :** 2 **Nb personnels :** 6

N° Intervention : [redacted] CSTC : [redacted] Opérateur : [redacted]
1er départ : **327 - Personne blessée par arme blanche**
Adresse d'intervention : [redacted]

Numéro Requérant : [redacted] **Téléphone portable** Numéro Impliqué : [redacted]
Heure de décroché : **12:50:36**
Informations requérants :

devant la mairie // h 20 ans // coup de couteau //

info adresse :

info site :

Bilan du VSAV

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : un homme nous dit avoir reçu des coups de couteau en marge d'une rixe

Situation à l'arrivée des secours : 6 coups couteau (couteau de cuisine selon le requérant)
plaies 1cm pour chaque non hémorragique
->cuisse gauche x2
-> dorsal côté gauche
-> arrière épaule gauche
-> haut bras côté gauche

diff respi dues a l'utilisation de gaz lacrymogènes

pas de plaie tête

PARAMÈTRES VITAUX

	13:01	13:10	13:14
FC	90		91
PA BG	106/66		122/78
FR	19		
SpO2	98 %		98 %
SpO2 :: Dispositif	Air ambiant		Air ambiant
Hb	16.2 g/dL		
GCS	Y4 V5 M6 (15)		

CIRCULATION

Pouls régulier // Pouls radial perçu

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

Bilan de l'équipe médicale



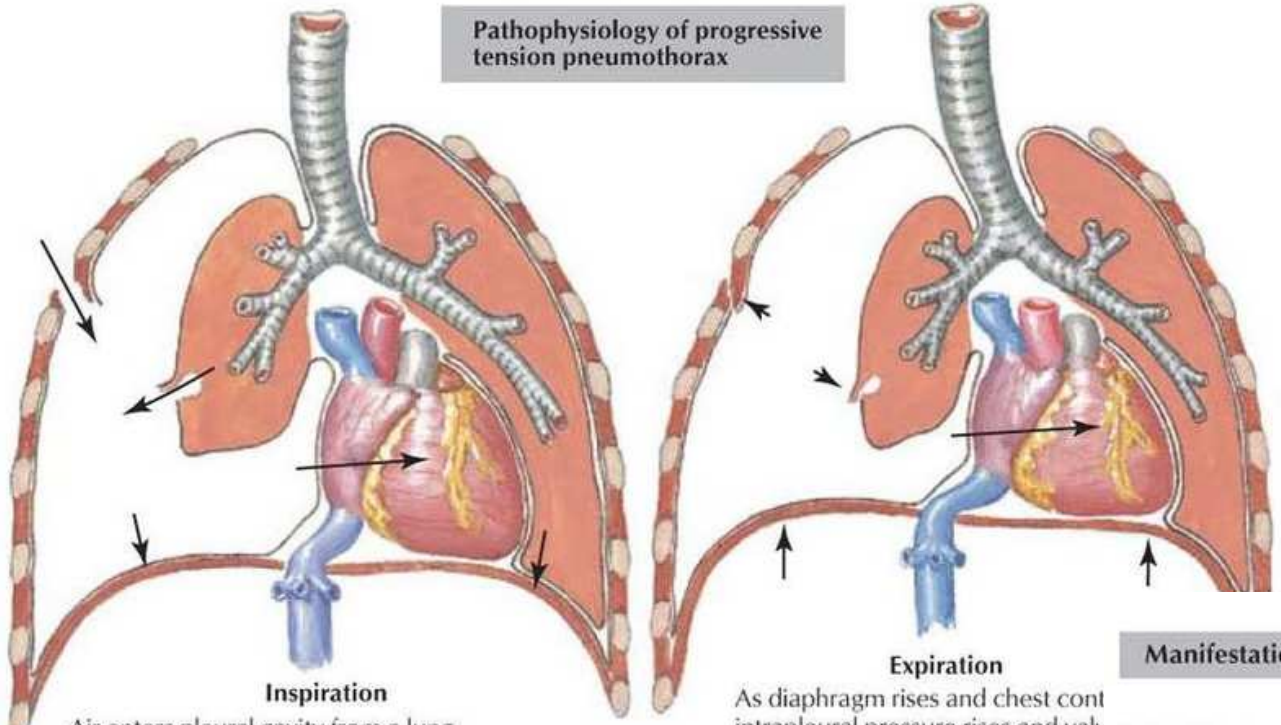


Évolution

- Brutalement, à 13h20 :
  - PAS 60 mmHg, sueurs profuses ;
  - désaturation avec nécessité d'augmenter l'oxygène ;
  - GCS 14 (mauvaise perfusion en oxygène du cerveau).
- L'équipe médicale doit réaliser un geste de sauvetage : exsufflation d'un pneumothorax.
- Ce geste lève la détresse respiratoire et la détresse circulatoire.



Pathophysiology of progressive tension pneumothorax



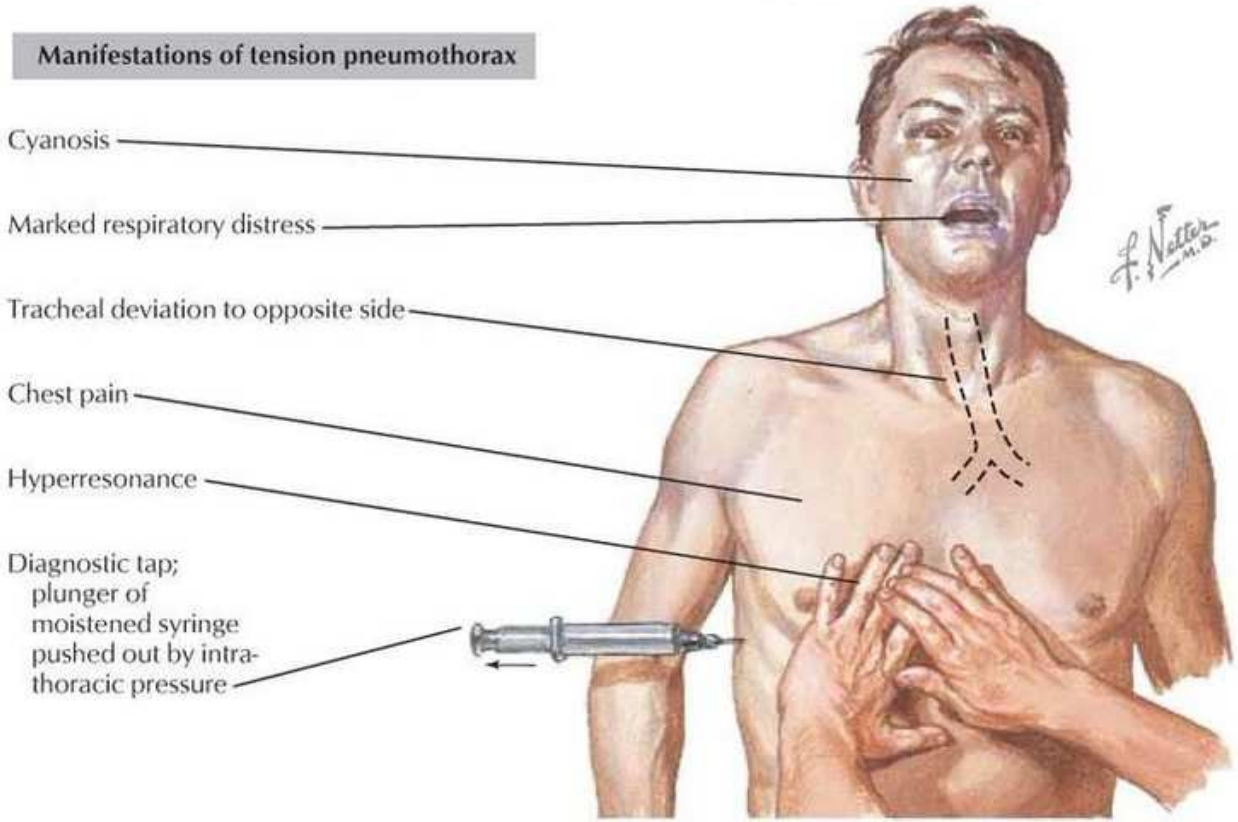
Inspiration

Air enters pleural cavity from a lung perforation (or rarely from an external chest wound). Lung collapses and mediastinum shifts to opposite side compressing contralateral lung and impairing its ventilating capacity

Expiration

As diaphragm rises and chest cont
intrapleural pressure rises and valv
opening through which air entere
Pressure is thus progressively incre
mediastinal shift augmented with
respiration. Venous return is impai
increased intrathoracic pressure a
distortion of venae cavae

Manifestations of tension pneumothorax



Pourquoi est-on au courant de cette intervention ?

Le chef d'agrès aurait été surpris de voir arriver une équipe médicale,

car lors de son bilan la victime allait bien...

La gravité des victimes est souvent masquée par l'arrivée rapide des secours :

PA faussement rassurante,

douleur absente du fait de l'activation du système sympathique...

Cas n°4

- Appel 18



BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

MAIN COURANTE OPERATIONNELLE

Dossier imprimé le : [redacted]

Fiche décisionnelle : ATR14 - TRAUMATISME MEMBRE INFERIEUR

Mission BSPP - Procédure Blanche [redacted] 06:43:54

Nb LSO impliqués : 1 **Nb moyens sur interventions :** 2 **Nb personnels :** 6

N° Intervention : [redacted] CSTC : [redacted] Opérateur : [redacted]

1er départ : **302 - Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...)**

Adresse d'intervention : [redacted]

Numéro Requérant : [redacted] **Téléphone portable** Numéro Impliqué : [redacted]

Heure de décroché : [redacted] **06:43:54**

Informations requérants :

SUR VP // F25 // CHUTE D'UN PONT DANS L'EAU // SORTIE // TRAUMA CHEVILLE // DEFORMATION // GONFLEMENT

info adresse :

info site :



- Bilan du CA en non-urgent



BILAN PROMPT-SECOURS

MOTIFS DE RECOURS

Chute de 3m ou plus (défenestration, chute de hauteur)

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : Une homme de 25 ans escalade un pont, glisse et chute sur une partie betonné et termine dans la Seine.

Situation à l'arrivée des secours : Lesionnel :

- Trauma cheville GAUCHE : gonflement sur le haut du pied
- Motricité possible mais douloureuse
- Sensibilité RAS
- TRC inf a 3sec
- Pouls pedieux perçu
- Chaleur du membre Ras
- pas de TC
- pas de douleur rachis cervical thoracique lombaire

Neuro :

- pas de pci ni malaise
- bien orienté temps espace
- pas de nausées ni vomissement

Se plaint du froid mais température dans la norme /
Consommation d'alcool + stupéfiants (2 rails de 3 MMC)

Victime n°1

PARAMÈTRES VITAUX

	07:14	08:02
FC	95	81
PA BG	153/99	155/75
FR	16	18
SpO2	99 %	100 %
SpO2 :: Dispositif	Air ambiant	Air ambiant
Température	35.6 °C	
Glycémie	5.3 mmol/L	
GCS	Y4 V5 M6 (15)	

COMMENTAIRE

env 3 à 4 m /

CIRCULATION

Pouls régulier // Pouls radial perçu

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

BILAN SPÉCIFIQUE PROMPT-SECOURS : CHUTE

Chute : D'un bâtiment (défenestration, ...)Hauteur de la chute : 3Désignation : Mètres

Rassurant ?

Pas de TC

Pas de signes respiratoires ou circulatoire

Pas de douleur du rachis
Pas de déficit SM des membres

GCS 15, pas de PCI

Constantes normales

Inquiétant ?

Chute sur les pieds depuis plus de 3m

Intoxication alcoolique et aux stupéfiants associée au traumatisme

Manquant ?

Thorax

Abdomen

Bassin

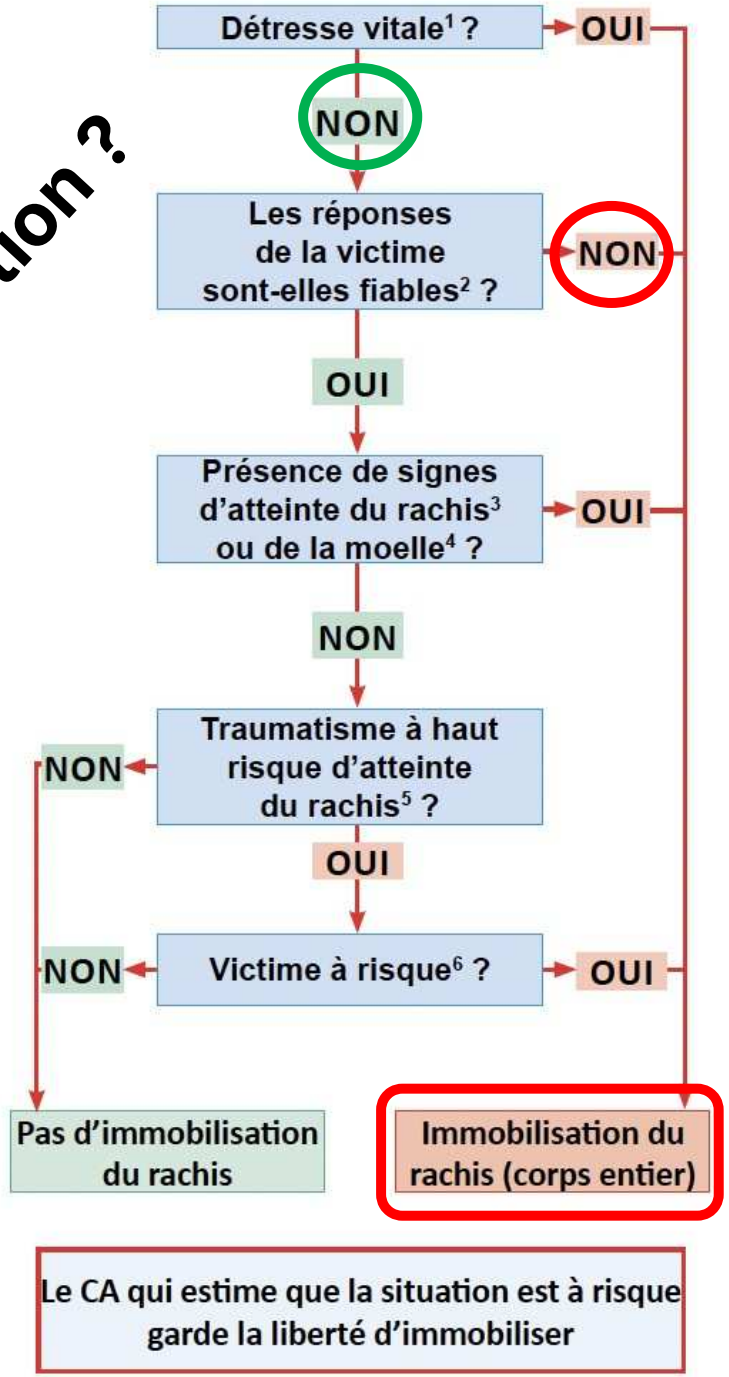
Reste des membres

MHTA

Incertain ?

Cheville

Et l'immobilisation ?



(1) Victime présentant une détresse vitale

❑ Présence d'une détresse vitale :
- PCI ou Glasgow < 14.
- Absence de pouls radial au bilan primaire ou PAS <90 mmHg.
- Signes détresse respiratoire.

(2) Victime dont les réponses sont qualifiées de NON fiables:

❑ Non coopération, difficultés de communication (agitation, barrière de la langue).
❑ Influence de l'alcool ou d'autres drogues.
❑ Présence d'une atteinte traumatique sévère (tête – tronc)
❑ Douleur distractive associée à une situation à haut risque du rachis décrite dans **(5)**

(3) Signes d'atteinte du rachis à rechercher dans l'ordre :

❑ 1/ Déformation évidente du rachis.
❑ 2/ Douleur spontanée siégeant au niveau du rachis.
❑ 3/ Douleur à la palpation prudente du rachis.
❑ 4/ Raideur de la nuque empêchant de tourner la tête.
❑ 5/ Douleur du rachis à la mobilisation, à la marche.

(4) Signes d'atteinte de la moelle épinière

❑ Perte ou diminution de la force musculaire ou de la motricité des mains ou des pieds (difficulté de serrer les mains, de bouger les orteils, de bouger un ou plusieurs membres).
❑ Sensibilité :
- perte ou diminution de la sensibilité des membres supérieurs ou inférieurs.
- engourdissement, fourmillements, décharges électriques au niveau des membres (paresthésies).

❑ Perte des urines ou des matières fécales.
❑ Erection.

(5) Situations à haut risque de fracture du rachis

❑ Chute sur la tête d'une hauteur > 1 mètre comme lors d'un plongeon (rachis cervical) ou chute sur les pieds ou les fesses d'une hauteur > 3 mètres (rachis dorso-lombo-sacré).
❑ Occupant d'un véhicule accidenté à grande vitesse (vitesse > 40 km/h) ou avec arrêt brutal contre un obstacle ou décélération sur une courte distance < 10m ou déformation de l'habitacle.
❑ Absence de port de ceinture de sécurité (et déclenchement des airbags).
❑ Retournement d'un véhicule (tonneaux) à la suite d'une collision.
❑ Victime éjectée d'un véhicule lors de la collision.
❑ Accidents avec des véhicules à moteur de loisir (jet-ski, quad, kart, trottinettes électriques…).
❑ Accident de 2 roues - conducteur ou passager(s).
❑ Piéton renversé.
❑ Chute de cheval.

(6) Antécédents à risque

❑ Traumatisme vertébral ancien (fracture, luxation)
❑ Chirurgie de la colonne vertébrale.
❑ Maladie de la colonne vertébrale ou des os qui fragilise la colonne vertébrale (ostéoporose)

BILAN PROMPT-SECOURS

MOTIFS DE RECOURS

Chute de 3m ou plus (défenestration, chute de hauteur)

Victime n°2

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : Une femme de 26 ans escalade un pont, glisse et chute sur une partie betonné et termine dans la Seine.

Situation à l'arrivée des secours : Lesionnel :

- Trauma cheville droite : gonflement de la maleole
- Motricité possible mais douloureuse
- Sensibilité RAS
- TRC inf a 3sec
- Pouls pedieux perçu
- Chaleur du membre Ras

- Douleur rachis lombaire : sans déformation/ pas de rougeur / pas de gonflement
- pas de TC

Neuro :

- pas de pci ni malaise
- bien orienté temps espace
- pas de nausées ni vomissement

Se plaint du froid mais température dans la norme /
Consommation d'alcool + stupéfiants (2 rails de 3 MMC)

TRAITEMENTS EN COURS

Aucun traitement : Oui

ANTÉCÉDENTS

Aucun antécédent : Oui

PARAMÈTRES VITAUX

	07:03
FC	110
PA BG	152/123
FR	16
SpO2	98 %
SpO2 :: Dispositif	Air ambiant
Température	36.0 °C
Glycémie	6.6 mmol/L
GCS	Y4 V5 M6 (15)

COMMENTAIRE

chute même endroit /

CIRCULATION

Pouls régulier // Pouls radial perçu

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

BILAN SPÉCIFIQUE PROMPT-SECOURS : CHUTE

Chute : D'un bâtiment (défenestration, ...)Hauteur de la chute : 3Désignation : Mètres

Rassurant ?

Pas de TC

Pas de signes respiratoires ou circulatoire

Pas de déficit SM des membres

GCS 15, pas de PCI

FR et saturation normales

MHTA néant

Inquiétant ?

Chute sur les pieds depuis plus de 3m

Traumatisme du rachis

Intoxication alcoolique et aux stupéfiants associée au traumatisme

Tachycardie et PA pincée

Manquant ?

Thorax ?

Abdomen ?

Bassin ?

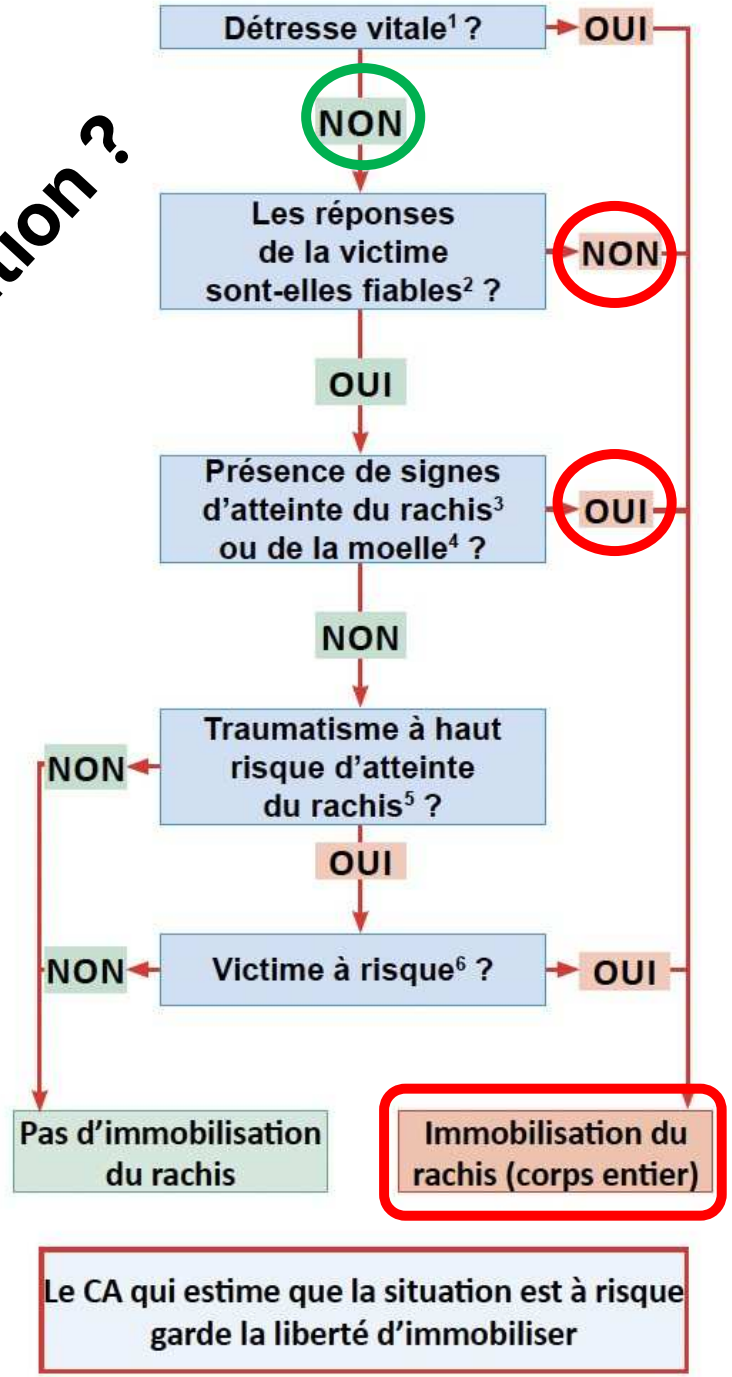
Reste des membres ?

Pas de reprise de constantes

Incertain ?

Cheville

Et l'immobilisation ?



(1) Victime présentant une détresse vitale

- ❑ Présence d'une détresse vitale :
  - PCI ou Glasgow < 14.
  - Absence de pouls radial au bilan primaire ou PAS <90 mmHg.
  - Signes détresse respiratoire.

(2) Victime dont les réponses sont qualifiées de NON fiables:

- ❑ Non coopération, difficultés de communication (agitation, barrière de la langue).
- ❑ Influence de l'alcool ou d'autres drogues.
- ❑ Présence d'une atteinte traumatique sévère (tête – tronc)
- ❑ Douleur distractive associée à une situation à haut risque du rachis décrite dans **(5)**

(3) Signes d'atteinte du rachis à rechercher dans l'ordre :

- ❑ 1/ Déformation évidente du rachis.
- ❑ 2/ Douleur spontanée siégeant au niveau du rachis.
- ❑ 3/ Douleur à la palpation prudente du rachis.
- ❑ 4/ Raideur de la nuque empêchant de tourner la tête.
- ❑ 5/ Douleur du rachis à la mobilisation, à la marche.

(4) Signes d'atteinte de la moelle épinière

- ❑ Perte ou diminution de la force musculaire ou de la motricité des mains ou des pieds (difficulté de serrer les mains, de bouger les orteils, de bouger un ou plusieurs membres)
- ❑ Sensibilité :
  - perte ou diminution de la sensib… …érieurs.
  - engourdissement, fourmillemen… …des membres (paresthésies).
- ❑ Perte des urines ou des matières féca…
- ❑ Erection.

Et de toutes les façons !

(5) Situations à haut risque de fracture du rachis

- ❑ Chute sur la tête d'une hauteur > 1 mètre comme lors d'un plongeon (rachis cervical) ou chute sur les pieds ou les fesses d'une hauteur > 3 mètres (rachis dorso-lombo-sacré).
- ❑ Occupant d'un véhicule accidenté à grande vitesse (vitesse > 40 km/h) ou avec arrêt brutal contre un obstacle ou décélération sur une courte distance < 10m ou déformation de l'habitacle.
- ❑ Absence de port de ceinture de sécurité (et déclenchement des airbags).
- ❑ Retournement d'un véhicule (tonneaux) à la suite d'une collision.
- ❑ Victime éjectée d'un véhicule lors de la collision.
- ❑ Accidents avec des véhicules à moteur de loisir (jet-ski, quad, kart, trottinettes électriques…).
- ❑ Accident de 2 roues - conducteur ou passager(s).
- ❑ Piéton renversé.
- ❑ Chute de cheval.

(6) Antécédents à risque

- ❑ Traumatisme vertébral ancien (fracture, luxation)
- ❑ Chirurgie de la colonne vertébrale.
- ❑ Maladie de la colonne vertébrale ou des os qui fragilise la colonne vertébrale (ostéoporose)

Bilan au médecin CM

- Bilan au médecin : il confirme la nécessité de demander un second VSAV pour immobiliser correctement les 2 victimes (ce que l'OCM avait déjà dit au VSAV).

Pourquoi est-on au courant de cette intervention ?

- Appel du médecin des urgences qui tombe sur l'opérateur



Pièges en traumatologie

- Gravite masquée car intervention précoce : PA faussement rassurante, douleur absente…
- Victime debout ou enveloppe corporelle intacte
- Engins de déplacements sans EPI (vélo, trottinette, gyropode), avec vitesse « basse » qui est faussement rassurante
- Victime intoxiquée (alcool, stupéfiants), victime démente
- Victime prenant des médicaments qui fluidifient le sang
- Victime retrouvée en bas d'un immeuble : défenestrée ?
- Douleur = lésion ! (« douleur des côtes » = traumatisme thoracique !)
- Douleur distractive
- Fourmillements = déficit sensitif qui s'installe !
- Ne pas tenir compte de la cinétique
- Ne pas connaître son hôpital de secteur/de proximité
- Ne pas surveiller la victime pendant le transport
- Certaines victimes qui paraissent aller bien ont en réalité une ou plusieurs lésions graves, ce qui impose une application non négociable des immobilisations

Le traumatisé sévère

- Les circonstances :
  - Chute supérieure à 3 mètres
  - Éjection d'un véhicule, victime projetée ou écrasée
  - Vitesse supérieure à 40 km/h
  - Autre passager décédé
  - Appréciation globale : déformation du véhicule, pas d'organes de sécurité, véhicules à moteur sans protection du corps
  - Chute de cheval, explosion
- Le bilan :
  - Lésion tête ou tronc
  - GCS < 14
  - Hypotension, précédée par tachycardie
  - SpO2 < 94 %
- La Golden Hour :
  - 10' hors de l'hôpital = 4 % de mortalité en plus !
  - Donc : anticiper relevage, immobilisation, déshabiller et réchauffer, identité, escorte, hélicoptère

AUCUN DOUTE SUR LA GRAVITÉ !

Retenir 3 grands messages

- Une plaie pénétrante n’est pas une estafilade.
- L’atteinte de la tête et/ou du tronc est souvent grave.
- Les traumatismes du rachis doivent être immobilisés selon l’algorithme, car ils peuvent cacher des lésions médullaires dramatiques.